



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Nomor : 24/TKMKBPUSAT/0726
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Audit Medis Tahun 2026
Tema Sectio Caesarea

Jakarta, 07 Juli 2026

Yth. Direktur Utama
BPJS Kesehatan
di
Tempat

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan audit medis dengan tema sectio caesarea yang telah dilakukan oleh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama organisasi/perhimpunan profesi, serta TKMKB Tingkat Provinsi dan Tingkat Cabang, telah diidentifikasi sejumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut melalui rekomendasi perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan rekomendasi TKMKB Tingkat Pusat sebagaimana terlampir. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPJS Kesehatan beserta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, khususnya pada pelayanan sectio caesarea.

Untuk memastikan efektivitas implementasinya, setiap rekomendasi diharapkan ditindaklanjuti melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu layanan serta efisiensi pembiayaan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ketua TKMKB Tingkat Pusat



(Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp. U (K))

Tembusan

1. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan - BPJS Kesehatan
2. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat - BPJS Kesehatan
3. Ketua PP POGI
4. TKMKB Provinsi di Seluruh Indonesia
5. TKMKB Cabang di Seluruh Indonesia

REKOMENDASI HASIL AUDIT MEDIS
TEMA *SECTIO CAESAREA*
TKMKB PUSAT

Audit medis telah dilakukan untuk kasus *sectio caesarea* oleh TKMKB Pusat, TKMKB Provinsi Bali, dan TKMKB Cabang Denpasar bersama dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia pada tahun 2026 untuk kasus yang telah dilayani pada periode tahun 2025. Bersama ini disampaikan rekomendasi hasil audit medis kasus *Sectio Caesarea* (SC) yang telah disusun sebagai berikut:

I. Temuan Hasil Audit Medis

1. Kesalahan input diagnosis yang tertera di resume medis pada pengajuan klaim, seperti persalinan normal ditagihkan SC dan inkonsistensi diagnosis.
2. Ketidaksesuaian resume medis dan dokumen pengajuan klaim.
3. Ketidaktepatan indikasi SC:
 - a. Kriteria bekas 2 kali SC tidak dapat dibuktikan, hanya terdapat riwayat 1 kali SC.
 - b. Jarak SC pasca indikasi bekas SC atau *Locus Minoris Resistentiae* (LMR) sebelumnya yang tertuang dalam klaim < 18 bulan, namun tidak sesuai dengan data faktualnya.
 - c. Belum terdapat justifikasi dan indikasi medis yang adekuat untuk kasus kehamilan bekas SC dan ketuban pecah dini. Justifikasi klinis untuk melakukan SC pada kasus ini seharusnya meliputi adanya febris, lama ketuban pecah dini > 24 jam, atau ada kelainan obstetrik lain yang mendasari.
 - d. Belum terdapat justifikasi yang adekuat untuk persalinan SC pada pasien primi muda, dikarenakan tidak ditemukan kondisi/ indikasi obstetrik lain yang mendukung untuk dilakukan SC
4. Kriteria TOLAC (*Trial of Labor After Caesarean*) tidak diisi.
5. Ketidaklengkapan dokumen pendukung untuk indikasi emergensi pada kasus SC dengan pintu masuk IGD, seperti cardiotocography (CTG).
6. Ditemukannya *over treatment* pada sampel data.
7. Diagnosis infeksi pada kehamilan (ISK) tidak adekuat karena belum didukung dengan dokumen pendukung yang cukup.
8. Ketidaksesuaian antara indikasi yang disampaikan yaitu letak lintang, namun pada berkas klaim tertulis presentasi kepala janin.
9. Ketidaktepatan bukti pendukung klaim (tanggal pada laporan operasi tidak sesuai).
10. Terdapat kecenderungan pemilihan tanggal cantik pada kasus elektif dengan pintu masuk IGD.
11. Terdapat resume medis yang tidak lengkap dan tidak terbaca dengan jelas.

II. Rekomendasi Medis

Kriteria medis atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit medis:

1. Semua inpartu harus disikapi sebagai emergency dan harus dilakukan *Cardiotocography* (CTG)/ *Non-Stress Test* (NST) sebagai dasar (*admission test*) serta bukti pendukung (bukti cetaknya) dan interpretasinya.
2. Primi gravida dengan ketuban pecah dini bukan indikasi SC.
3. Bekas *sectio caesarea*, letak kepala dengan ketuban pecah dini diupayakan persalinan ekspektatif per vaginam sampai dengan 1x24 jam terhitung mulai pecah ketuban kecuali pada kondisi demam atau *fetal distress*. Untuk itu perlu dilakukan observasi *core temperature* (rektal atau timpani temperature) per 3 jam, denyut jantung janin (DJJ), HIS (kontraksi), dan kualitas air ketuban serta tanda-tanda inpartu.
4. Bila didapatkan *fetal distress* harus disertai dengan pembuktian atas penanganan *fetal distress* (resusitasi intrauteri).
5. Ketuban pecah dini harus ada pemeriksaan temperatur inti (*core temperature*) untuk penilaian febris.
6. Bila terdapat diagnosis sekunder tambahan, harus dipastikan penanganan terhadap diagnosis sekunder tambahan tersebut, misalnya infeksi saluran kemih (ISK) terdapat pemeriksaan urine lengkap yang mendukung.

III. Rekomendasi kepada Pemangku Kepentingan

1. Untuk FKRTL:
 - a. Fasilitas kesehatan agar memastikan kesesuaian dengan standar layanan.
 - b. Fasilitas Kesehatan agar membuat dan menerapkan PPK yang mengacu pada PNPK atau pedoman pelayanan yang berlaku nasional.
 - c. Fasilitas kesehatan agar memastikan kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan pengisian pada rekam medis termasuk yang diajukan dalam dokumen pengajuan klaim dan mempertanggungjawabkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
 - d. Ketentuan CTG bersifat wajib.
 - e. Pengisian rekam medis agar jelas, lengkap, tepat dan dapat terbaca.
 - f. Agar RS memiliki TKMKB RS yang akan melakukan fungsi kontrol.
2. Untuk Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia:
 - a. Pembuatan konsensus/ panduan nasional terkait indikasi SC.
 - b. Pembuatan kriteria indikasi medis SC dalam bentuk ceklis (seperti TOLAC).
 - c. Pembuatan konsensus/ panduan nasional terkait indikasi SC termasuk pada pasien yang mengalami jaringan parut uteri akibat tindakan sebelumnya atau indikasi jarak persalinan SC sebelumnya (<18 bulan berisiko naik).
 - d. Dibutuhkan penetapan untuk melampirkan *Cardiotocography* (CTG)/ *Non-Stress Test* (NST) pada kasus persalinan saat admission.

- e. Mengingatkan seluruh anggota untuk melakukan tindakan medis sesuai indikasi, SOP, PNPK, PPK, serta sesuai dengan kode etik yang berlaku.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPK FKRTL agar mengacu pada PNPK atau pedoman pelayanan yang berlaku nasional.
3. Untuk Kementerian Kesehatan :
- a. Melakukan pengawasan terhadap layanan kesehatan yang rasional dalam program JKN.
 - b. Mendorong penetapan PNPK SC.
4. Untuk BPJS Kesehatan:
- a. Mendorong dan membantu pada pelaksanaan *utilization review* oleh RS untuk dilakukan secara rutin.
 - b. Bersama-sama dengan stakeholder terkait melakukan koordinasi dan komunikasi terkait data-data anomali (*red flag*) yang dilakukan pada *utilization review* secara rutin.
 - c. Pro aktif membuat *Memorandum of Agreement* (MoA) bila terdapat kekosongan panduan klinis yang bersifat nasional.
 - d. Melakukan tindak lanjut atas hasil audit medis yang telah dilakukan.